

 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA	Nomor Standar Operasional Prosedur	013/IGD/HK.01.10/RSTK
	Tgl Pembuatan	05/08/2022
	Tgl Revisi	05/02/2025
	Tgl Pengesahan	18/02/2025
	Disahkan Oleh	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja,  Feurah Dihan Bahar NIP. 196805161994012004
	Nama Standar Operasional Prosedur	PENANGANAN PASIEN GAWAT DARURAT

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan 2. Keputusan Direktur RSUD Tugu Koja Nomor 67 Tahun 2022 tentang Format / Tata Naskah (Kebijakan, Pedoman, Panduan, dan SPO) Akreditasi RSUD Tugu Koja 3. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur	1. Dokter umum bersertifikat ACLS 2. Dokter spesialis 3. Perawat DIII atau Ners bersertifikat BTCLS 4. Analis Laboratorium bersertifikat Phlebotomy 5. Radiografer 6. Apoteker atau Asisten Apoteker 7. Petugas administrasi umum 8. Driver Ambulance bersertifikat FAB 9. Tenaga Kesehatan yang memiliki STR dan SIP yang berlaku
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SPO Triage 2. SPO Pemeriksaan Radiologi Pasien IGD 3. SPO Pemeriksaan Laboratorium Pasien IGD 4. SPO Transportasi Pasien Keluar RSUD Tugu Koja 5. SPO Prosedur Pelayanan Ambulance Keluar RSUD Tugu Koja 6. SPO Penanganan Pasien <i>Death on Arrival</i> (DOA)	1. Laptop/ERM 11. <i>Humidifier</i> 2. Alat pengukur tanda vital 12. Abocath 3. Stetoskop 13. Infus set 4. Brankar 14. Sput 5. Tiang Infus 15. <i>Tourniquet</i> 6. Kursi Roda 16. <i>Microphore</i> 7. Selang oksigen 17. <i>Swab</i> Alkohol 8. Masker inhalasi 18. <i>Stretcher</i> 9. <i>Flowmeter</i> 19. Gelang identitas 10. Monitor 20. EKG
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila prosedur alur Penanganan Pasien Gawat Darurat tidak dilaksanakan, dapat mengakibatkan ancaman nyawa pada pasien.	1. Register pasien IGD 2. Dokumentasi tindakan medis dan keperawatan 3. Data rujukan pasien

SOP PENANGANAN PASIEN GAWAT DARURAT

No	Kegiatan	Pelaksana												Mutu Baku			Ket
		Kamar Jenazah	Keamanan	Kasir	Farmasi	Perawat	Dokter	Laboratorium	Radiologi	Ranap	Loket	DPJP	Ambulans	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Perawat melakukan triase pada pasien													Komputer, ERM	5 menit	Data Triase	
2	Perawat menempatkan pasien di ruang tindakan/ observasi/ resusitasi sesuai skala prioritas triase													Bed pasien	1 menit	Pasien siap diperiksa	
3	Dokter jaga melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik pasien, serta membuat diagnosa kerja													Stetoskop, ERM	5 menit	Diagnosa medis	
4	Petugas loket mendaftarkan pasien ke dalam Sistem Informasi Rumah Sakit													Komputer, ERM	5 menit	Pasien terdaftar ke dalam SIMRS	
5	Dokter jaga menemukan tanda-tanda kematian													Stetoskop, penlight	5 menit	Pasien ditemukan tanda-tanda kematian	
6	Perawat melakukan pemeriksaan EKG													EKG	5 menit	Hasil pemeriksaan EKG	
7	Dokter jaga menyatakan pasien meninggal (<i>Death on Arrival</i> atau triase hitam)						1	2						Hasil pemeriksaan EKG	1 menit	Pasien dinyatakan meninggal	



8	Dokter membuat Surat Keterangan Penyebab Kematian							1	2							Surat Keterangan Penyebab Kematian	5 menit	Surat Keterangan Penyebab Kematian yang sudah terisi lengkap	
9	Petugas kasir memproses administrasi pasien															Komputer, ERM	5 menit	Keluarga pasien menyelesaikan administrasi	
10	Perawat melakukan perawatan jenazah															Kassa gulung, gunting	10 menit	Jenazah siap untuk dipindahkan ke ruang transit	
11	Perawat melakukan serah terima jenazah dengan petugas keamanan															Formulir serah terima jenazah	5 menit	Jenazah siap untuk dipindahkan ke ruang transit	
12	Petugas keamanan mengantar jenazah ke ruang transit jenazah															Brankar	5 menit	Jenazah tiba di ruang transit jenazah	
13	Dokter jaga melakukan penanganan kegawatdaruratan dan menginstruksikan perawat untuk memberikan terapi obat															Abocath, Spuit, obat, alkohol swab, tourniquet, microphore, masker inhalasi	10 menit	Pasien mendapatkan tindakan kegawatdaruratan dan terapi sesuai kebutuhan	
14	Dokter mengobservasi pasien															Monitor pasien	60 menit	Kondisi pasien terpantau	
15	Dokter mengajukan permintaan pemeriksaan penunjang															ERM	60 menit	Hasil pemeriksaan penunjang	



16	Dokter meresepkan obat dan BMHP yang dibutuhkan pasien							3	4	5					ERM	5 menit	Resep terinput di farmasi	
17	Petugas farmasi menyiapkan obat dan BMHP														ERM, obat, BMHP	15 menit	Obat dan BMHP pasien siap	
18	Dokter memulangkan pasien														ERM	2 menit	Pasien selesai diberikan pelayanan di IGD	
19	Petugas kasir menyelesaikan administrasi pasien (khusus umum)														Komputer, ERM	5 menit	Keluarga pasien menyelesaikan administrasi	
20	Pasien mengambil obat di farmasi kemudian pulang														Obat	15 menit	Pasien selesai diberikan pelayanan di Rumah Sakit	
21	Dokter melakukan konsultasi ke DPJP sesuai dengan kasus pasien														Whatsapp, ERM	15 menit	Pasien mendapatkan rencana perawatan medis dari DPJP sesuai kebutuhan	
22	DPJP memberikan instruksi medis kepada dokter jaga														Whatsapp, ERM	30 menit	Dokter jaga mendapatkan instruksi medis dari DPJP	
23	Dokter jaga membuat surat perintah rawat inap														ERM	2 menit	Pasien mendapatkan surat pengantar rawat inap	
24	Dokter mengarahkan keluarga pasien untuk mendaftar rawat inap														ERM	2 menit	Pasien terdaftar rawat inap dan mendapatkan kamar rawat inap	
25	Petugas loket mendaftarkan rawat inap dan memesan kamar														ERM	15 menit	Pasien mendapatkan ruang rawat inap	



26	Dokter meresepkan obat dan BMHP yang dibutuhkan oleh pasien						6						7	ERM	15 menit	Terapi untuk pasien disiapkan oleh farmasi	
27	Farmasi menyiapkan obat dan BMHP pasien													ERM, obat, BMHP	15 menit	Obat dan BMHP pasien siap	
28	Perawat memberikan terapi sesuai instruksi DPJP													Abocath, infus set, obat, tourniquet, infuse pump, microphore, alkohol swab, tiang infus, spuit	5 menit	Pasien mendapatkan terapi medis dari DPJP	
29	Perawat dan dokter membuat dokumentasi tindakan													Komputer, ERM	15 menit	Tindakan medis dan keperawatan terdokumentasi	
30	Perawat mengantarkan pasien ke ruang rawat inap/ICU/OK													Kursi roda, brankar	15 menit	Pasien masuk ke ruang rawat	
31	Dokter menyiapkan surat rujukan dan persetujuan													ERM	15 menit	Surat rujukan dan persetujuan pasien/keluarga	
32	Dokter mengajukan permintaan rujukan eksternal melalui jejaring SPGDT dan/atau SISROUTE													ERM, Whatsapp SPGDT, aplikasi SISROUTE	60-120 menit	Data kebutuhan rujukan pasien tersampaikan ke RS tujuan	
34	Dokter mengajukan permintaan ambulans													Whatsapp SPGDT	5 menit	Ambulans bersiap untuk mengantar pasien	
35	Perawat dan dokter (bila perlu) merujuk pasien menggunakan Ambulans													Alat pengukur tanda-tanda vital	30-60 menit	Pasien dirujuk	

